ZJLC73-2024-0004

舟山市医疗保障局
舟山市民政局
舟山市财政局 文件
舟山市卫生健康委员会
舟山市残疾人联合会

舟医保发〔2024〕8号

舟山市医疗保障局 舟山市民政局 舟山市财政局 舟山市卫生健康委员会 舟山市残疾人联合会关于印发舟山市长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）的通知

各县（区）医疗保障局、民政局、财政局、卫生健康局、残疾人联合会:

现将《舟山市长期护理保险失能等级评估管理办法（试

行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

舟山市医疗保障局　　舟山市民政局

舟山市财政局　　舟山市卫生健康委员会

舟山市残疾人联合会

2024年3月8日

舟山市长期护理保险
失能等级评估管理办法（试行）

第一章　总则

第一条　为加强长期护理保险(以下简称长护险)失能等级评估管理，保障参保人合法权益，根据《国家医保局财政部关于印发长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》的通知》（医保发〔2023〕29号）、《舟山市人民政府办公室关于印发舟山市构建多层次长期护理保障体系实施方案的通知》（舟政办发〔2024〕10号）、《关于印发舟山市构建多层次长期护理保障体系实施细则的通知》(舟医保发〔2024〕7号）等精神，制定本办法。

第二条　本办法适用于舟山市范围内的长护险失能等级评估工作。

第三条　本办法所称长护险失能等级评估，是指依据《长期护理保障失能等级评估规范》（浙江省地方标准DB33/T2476-2022），对评估对象日常生活活动能力、认知能力、感知觉与沟通能力等方面的能力丧失程度的分级评估。依本办法作出的评估结论是长护险基金支付待遇的必要依据。

第四条　长护险失能等级评估包括初次评估、定期评估、状态变更评估、争议复评、抽查复评和稽核复评。

第五条　长护险失能等级评估的结论分为四级，分别为基本正常、轻度失能、中度失能、重度失能，其中重度失能

细分为重度失能Ⅰ级、重度失能Ⅱ级、重度失能Ⅲ级。

第六条　长护险失能等级评估工作坚持“公平、公正、属地、就近、便民”原则独立进行，不受行政机关、社会团体、企业和个人的干涉，接受社会监督。实行统一的评估标准和方法，尊重和保护被评估对象的个人隐私，不得泄露被评估对象相关信息和资料。

第七条　市医保、民政、卫健、残联等部门共同组成市级长护险失能等级评估委员会，建立评估专家库，负责指导全市开展长护险失能等级评估工作，承担市本级辖区内失能等级评估事务。各县（区）设立相应的长护险失能等级评估委员会和专家库，具体负责辖区内长护险失能等级评估事务。

第八条　按照本办法开展长护险失能等级评估的结论在市域范围内实现跨部门、跨县(区)数据共享互认。根据国家和省规定逐步探索异地评估结论互认。

第九条　医保经办机构应建立完善长护险信息系统，提高评估全流程信息化、智能化管理水平，促进评估工作规范化、标准化。

第二章　评估组织和评估人员

第十条　全市各级长护险失能等级评估委员会组织评估人员开展失能等级评估工作，各乡镇（街道）、村（社区）和有关机构应配合做好相关工作。支持发展独立的评估机构，逐步推行评估机构定点管理和开展失能等级评估。

第十一条　评估人员是指符合一定条件，经专门培训合格，具体实施长护险失能等级评估的人员。评估人员包括评

估员、评估专家和核心评估专家。

（一）评估人员应具备以下基本条件：

1.参加规范化培训并考核合格，掌握长护险失能等级评估标准，熟悉评估操作要求，从事相关专业工作2年及以上;

2.具有良好的职业道德和操守，在工作中能够做到遵纪守法、廉洁自律、客观公正，相关行业领域无不良信用信息记录;

3.身体健康，具有较强的沟通能力，原则上不超过法定退休年龄。

（二）评估员。是指负责采集评估信息，协助开展现场评估的人员。担任评估员应具有医学、护理、康复、心理、长期照护、养老服务、管理等相关专业背景。

（三）评估专家。是指为参保人员进行初次评估、状态变更评估、定期复评的人员。担任评估专家应具有临床医学、护理、康复、精神心理等领域中级及以上职称，偏远海岛可适当放宽职称要求。

（四）核心评估专家。是指进行稽核评估、争议复评、抽查复评的人员。担任核心评估专家应具有临床医学、护理、康复、精神心理等领域副高及以上职称，在相关专业领域有较高业务水平及处理复杂病例能力。

第十二条　建立长护险失能等级评估人员库，评估人员的基本信息纳入长护险信息系统实行信息化管理，未纳入信息化管理的人员不得从事长护险失能等级评估工作。定期组织考核，明确准入退出机制。

第十三条　评估人员应当客观、公正地开展长护险失能等级评估工作，与被评估对象有亲属关系或利害关系的，应当申请回避。

第三章　评估流程

第十四条　初次评估。失能等级评估流程包括自评与申请、受理审核、现场评估、提出结论、公示与送达等流程。

（一）自评与申请

评估对象或其监护人、委托代理人自愿向辖区医保经办机构提出评估申请，申请前应对照《舟山市长期护理保险失能等级自评表》（附件1）进行自评，符合要求的方可正式提出评估申请。提交以下申请材料:

1.申请人有效身份证件、医保电子凭证或社会保障卡;由代理人办理的，一并提供代理人的有效身份证件;

2.《舟山市长期护理保险失能等级自评表》;

3.《舟山市长期护理保险失能等级评估申请表》(附件2);

4.提供证明参保人员失能状态持续6个月以上的相关材料，如门诊病历、出院小结、医疗诊断书等完整病历材料;

5.评估需要的其他材料。

评估申请可通过居住地所在村（社区）、也可就近选择长护险定点护理机构或政银合作机构为其提供申请服务，已入住长护险定点护理机构的由该机构协助申请。村（社区）、定点护理机构等应无偿为申请人提供申请服务，做好政策宣传、申请材料收集整理、协助自评等工作，对明显不符合失能标准的应退回申请，并做好相关政策解释工作。通过“浙

里长护在线”，全面推进失能等级评估线上申请。

（二）受理审核

村（社区）、定点护理机构或政银合作机构在接受或协助申请后，应即时将申请材料录入长护险信息系统。辖区医保经办机构应在5个工作日内完成受理审核。有以下情形之一的，不予受理失能等级评估申请:

1.未参加长护险的;

2.患病治疗期或失能状态持续未满6个月的;

3.距上次评估结论作出之日起，未满6个月的;

4.申请材料不全或提供虚假材料的;

5.因工伤或第三方原因导致伤残生活不能自理的;

6.其他不予受理情形。

不予受理的，医保经办机构应及时告知申请人或协助申请机构；申请材料不完整的，应一次性告知需要补正的材料。

（三）现场评估

申请审核通过后，辖区长护险失能等级评估委员会组织开展失能等级评估工作，在辖区评估人员库中随机抽取1名评估专家和1名评估员，与申请人约定时间后上门开展现场评估。现场评估时应至少有1名评估对象的监护人或委托代理人在场，在居家评估的应有所在地村（社区）相关工作人员在场，在定点护理机构评估的应有该机构相关负责人在场。

现场评估人员应按照《长期护理保障失能等级评估规范》开展信息采集等评估工作，如实填写《舟山市长期护理保险失能等级评估表》（附件3）并签字确认，评估过程应留下完

整的视频录像。必要时可在邻里、社区等一定范围内走访调查评估对象的基本生活自理情况，做好调查笔录和视频录像，并参考医院住院病历或诊断书等相关资料，作为提出评估结论的佐证资料。

（四）提出结论

现场评估结束后，评估人员在长护险信息系统中规范录入《舟山市长期护理保险失能等级评估表》内容，由长护险信息系统对照《舟山市长期护理保险失能等级划分表》（附件4）自动生成评估结论。辖区长护险失能等级评估委员会办公室应定期召开会议，组织不少于3名核心评估专家根据申请材料、现场评估情况、相关视频录像及其他资料，对评估结论进行确认。

（五）公示与送达

评估结论达到待遇享受条件对应失能等级的，医保经办机构应定期在辖区医保部门网站和相关村（社区）进行公示（公示模板见附件5），接受社会监督，公示期为3个工作日。

符合待遇享受条件经公示无异议的，或不符合待遇享受条件的，由辖区长护险失能等级评估委员会出具《舟山市长期护理保险失能等级评估结论书》（附件6），医保经办机构向评估对象或其监护人、委托代理人送达评估结论书。原则上评估结论书应在申请受理通过之日起30个工作日内送达。

第十五条　评估对象或其监护人、委托代理人应当积极配合开展现场评估工作。有以下情形之一的，评估终止：

（一）拒不接受失能等级评估信息采集的；

（二）无正当理由不配合失能等级评估的;

（三）其他原因导致失能等级评估终止的。

第十六条　定期评估。重度失能等级评估结论有效期为 2 年。评估有效期届满前，辖区长护险失能等级评估委员会组织对需继续享受长护险待遇的参保人员进行定期评估，其现场评估、提出结论、公示与送达的流程和规则参照初次评估。经定期评估符合待遇享受条件的，有效期届满后重新计算。

第十七条　争议复评。评估对象或其监护人、委托代理人对失能等级评估结论有异议的，可在收到评估结论书 5 个工作日内，携带相关材料向辖区医保经办机构提出复评申请，经审核同意后，在 10 个工作日内组织开展复评。

第三人对公示评估结论有异议的，可在公示期内向辖区医保经办机构实名反映情况，医保经办机构应在 5 个工作日内完成情况调查，经调查情况基本属实的，在 5 个工作日内组织开展复评。

争议复评工作由核心评估专家负责，原则上有不少于 2 名核心评估专家参加，争议复评结论作出之日起 5 个工作日内，由医保经办机构将《舟山市长期护理保险复评（抽查、稽核）评估结论书》（附件 7）送达申请人，复评结论为最终评估结论，不再公示。

第十八条　状态变更评估。参保人员失能状态发生变化、与评估结论不匹配，评估结论出具满 6 个月的，可向医保经办机构申请重新评估，评估的具体流程和规则参照初次评估。

第十九条　享受长护险待遇的失能人员发生下列情形之

一的，长护险待遇按以下办法执行:

（一）经定期复评、抽查复评、稽核评估未达到重度失能等级的，自评估结论下达的次月起停止享受长护险相关待遇;

（二）经状态变更评估、争议复评达到重度失能等级的，自评估结论下达的次月起享受长护险相关待遇;

（三）享受长护险待遇人员死亡的，自死亡次日起终止护理服务项目，次月起终止享受亲情护理待遇。

第二十条　评估费用。初次评估、定期评估、抽查复评、稽核复评的评估费用由长护险基金承担，状态变更评估、争议复评的评估费用先由申请人承担，评估结论发生改变的，评估费用由长护险基金承担。长护险失能等级评估费用标准根据实际需要确定。

第四章　监督管理

第二十一条　抽查复评。建立长护险失能等级评估抽查复评机制。对初次评估符合重度失能等级人员，辖区失能等级评估委员会应每季度组织核心评估专家开展抽查复评工作，原则上年度抽查比例不低于5%，抽查复评的流程和规则与争议复评相同。评估结论发生改变的，由医保经办机构将《舟山市长期护理保险复评（抽查、稽核）评估结论书》送达申请人。抽查复评结论为最终评估结论，不再公示。

第二十二条　稽核复评。建立长护险待遇日常巡查机制。由医保经办机构组织长护险日常巡查队伍，通过上门核实、邻里走访、定点护理机构核实及部门信息比对等方式，对享

受长护险待遇人员的失能程度和生存状况进行核查。经核查失能等级发生变化或不符合长护险待遇享受条件的，应发起稽核复评，评估流程和规则与争议复评相同，出具《舟山市长期护理保险复评（抽查、稽核）评估结论书》，作为最终评估结论，不再公示。

第二十三条　医保部门应对评估实施情况进行监督，完善智能审核和监控规则，强化智能监管。评估人员有下列情况之一的，终止评估服务资格。造成长护险基金损失的，按照有关法律法规处理；构成犯罪的，依法追究相应法律责任。

（一）评估人员年度3次以上被投诉，查证属实的；

（二）随机检查中发现评估人员出现严重失误的；

（三）弄虚作假作出评估结论的；

（四）出现违法、违规行为的；

（五）评估人员主动退出的。

第二十四条　申请人或代理人以欺诈、伪造证明材料或其他违法违规行为取得长护险待遇资格的，医保经办机构应取消其相关待遇；造成长护险基金损失的，按照有关法律法规处理；构成犯罪的，依法追究相应法律责任。

第二十五条　长护险失能等级评估工作接受社会和群众监督，任何组织和个人有权对长护险失能等级评估中的违法行为进行举报投诉。

第五章　附则

第二十六条　长护险失能等级评估具体经办业务，医保经办机构可委托经办合作机构共同承担。

第二十七条　本办法由舟山市医疗保障局负责解释，自发文之日起施行。

附件：1.《舟山市长期护理保险失能等级自评表》

2.《舟山市长期护理保险失能等级评估申请表》

3.《舟山市长期护理保险失能等级评估表》

4.《舟山市长期护理保险失能等级划分表》

5.《舟山市长期护理保险评估公示模板》

6.《舟山市长期护理保险失能等级评估结论书》

7.《舟山市长期护理保险失能等级复评（争议、抽查、稽核）评估结论书》

8.《舟山市长期护理保险失能等级评估结论书送达回执》

附件 1

舟山市长期护理保险失能等级自评表

姓名：　　身份证号码：　　填写时间：

项目		独立（2）	部分独立（1） (需要帮助)	依赖（0）	选项
A类	进食	无须帮助	自己能动手吃，但需辅助	不能独立完成，靠喂食或鼻饲	
	大小便控制	自己能够完全控制	偶尔失控	失控、不能自控，需帮助处理大小便(如导尿、 灌肠等)	
	洗澡	无须帮助，自己能进出浴室，独立洗澡	需帮助清洗部分身体(背部或腿)	不能独立完成洗澡	
B类	穿衣	无须帮助，能独立拿取衣服，穿上并扣好	能独立拿取衣服及穿上，需帮助系鞋带	不能独立完成穿衣，要靠他人拿衣、穿衣	
	用厕	无须帮助，能独立用厕及便后处理	需要帮助用厕及便后处理	不能用厕	
	床椅转移	无须帮助，自己能上、下床椅	需帮助上、下床椅	卧床不起	
综合	自评失能等级为：				
	A类3项依赖、A类2项依赖B类1项依赖、A类1项依赖B类3项依赖的人员，方可申请长期护理失能等级评估。				
	此表由评估对象或其监护人、代理人自行评估。				

附件 2

舟山市长期护理保险失能等级评估申请表

<table>
<tr><td rowspan="9">参保人员基本信息</td><td>姓名</td><td></td><td>身份证号</td><td></td></tr>
<tr><td>性别</td><td></td><td>年龄</td><td></td></tr>
<tr><td>民族</td><td></td><td>参保地</td><td></td></tr>
<tr><td>失能时长
(月数)</td><td>_____月</td><td>是否经过康复治疗</td><td>☐是，治疗月数_____月
☐否</td></tr>
<tr><td>是否首次申请</td><td>☐是　☐否</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>保障方式</td><td colspan="3">☐职工基本医疗保险　　☐城乡居民基本医疗保险</td></tr>
<tr><td>居住状况</td><td colspan="3">☐独居　☐与配偶/伴侣居住　☐与子女居住　☐与父母居住
☐与兄弟姐妹居住　　☐与其他亲属居住
☐与非亲属关系的人居住　　☐养老机构　☐医院</td></tr>
<tr><td>居住地址</td><td colspan="3">_____区/县_____街道/镇
_____社区/村_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">承诺事项</td><td colspan="3">本人承诺以上填写信息及提交材料真实有效，参保人当前护理 费用未享受工伤保险待遇、非第三方责任人承担、非政府公共卫生 经费承担。本人同意将评估结果在一定范围内公示。如有提供虚假 材料或瞒报漏报的，本人愿意承担相应法律责任。

申请人（监护人或代理人）签字:
监护人、代理人与申请人的关系：

年　　月　　日</td></tr>
</table>

附件 3

舟山市长期护理保险失能等级评估表

表 1　日常生活活动能力评估表

评估项目	能力表现	分值	得分
进食a	较大或完全依赖，或有留置营养管	0	
	需部分帮助(夹菜、盛饭)	5	
	自理(在合理时间内能独立使用餐具食用各种食物,可使用辅助工具独立完成进食，但不包括做饭)	10	
穿衣b	依赖他人	0	
	需要部分帮助(能自己穿脱衣服或假肢或矫形器，但需他人帮助整理衣物、系扣/鞋带、拉拉链等)	5	
	自理(自己系开纽扣，关开拉链和穿鞋、袜、假肢或矫形器等)	10	
面部与口腔清洁c	需要帮助	0	
	独立洗脸、梳头、刷牙、剃须(不包括准备洗脸水、梳子、牙刷等准备工作)	5	
大便控制	失禁(平均每周≥1 次或完全不能控制大便排泄，需要完全依赖他人)	0	
	偶有失禁(每周＜1 次)，或需要他人提示或便秘需要人工帮助取便	5	
	能控制	10	
小便控制	失禁(平均每天≥1 次或经常尿失禁，完全需要他人帮忙完成排尿行为；或留置导尿管，但无法自行管理导尿管)	0	
	偶有失禁(每 24h＜1 次，但每周＞1 次，或需要他人提示)	5	
	能控制(或留置导尿管，可自行管理导尿管)	10	
用厕	需要极大地帮助或完全依赖他人	0	
	需部分帮助(需他人帮忙整理衣裤、坐上/蹲上便器等)	5	
	自理(能够使用厕纸、穿脱裤子等)	10	

平地行走	卧床不起、不能步行、移动需要完全帮助	0	
	在较大程度上依赖他人搀扶(≥2 人)或依赖他人帮助使用轮椅等辅助工具才能移动	5	
	需少量帮助(需 1 人搀扶或需他人在旁提示或在他人帮助下使用辅助工具)	10	
	独立步行(自行使用辅助工具，在家及附近等日常生活活动范围内独立步行)	15	
床椅转移	完全依赖他人，不能坐	0	
	需大量帮助(至少 2 人，身体帮助)，能坐	5	
	需少量帮助(1 人搀扶或使用拐杖等辅助工具或扶着墙、周围设施，转移时需他人在旁监护、提示)	10	
	自理	15	
上下楼	不能，或需极大帮助或完全依赖他人	0	
	需要部分帮助(需扶着楼梯、他人搀扶、使用拐杖或需他人在旁提示)	5	
	独立上下楼(可借助电梯等，如果使用支具，需可独立完成穿、脱动作)	10	
洗澡	洗澡过程中需他人帮助	0	
	准备好洗澡水后，可自己独立完成	5	
评估对象姓名：　　评估人员：　　评估时间：			
a　指用餐具或其他辅具将食物由容器送到口中、咀嚼、吞咽等过程。 b　指穿脱衣服、系扣、拉拉链、穿脱鞋袜、系鞋带。 c　指洗脸、梳头、刷牙、剃须等。			

日常生活活动能力受损等级分为 4 档，按表 1 中分值累计情况确定受损等级：

a)能力完好：总分 100 分；

b)轻度受损：总分 65 分~95 分；

c)中度受损：总分 45 分~60 分；

d)重度受损：总分 0~40 分。

表 2　认知能力评估

项目	能力表现	分值	得分
时间定向	无时间观念	0	
	时间观念很差，年、月、日不清楚，可知上午或下午	1	
	时间观念较差，年、月、日不清楚，可知上半年或下半年	2	
	时间观念有些下降，年、月、日清楚，但有时相差 1 周以上	3	
	时间观念(年、月、日、时)清楚	5	
空间定向	不能单独外出	0	
	只能在左邻右舍间串门，对现住地不知名称和方位	1	
	只能单独在家附近行动，对现住地只知名称，不知道方位	2	
	可单独来往于近街，知道现住地的名称和方位，但不知回家路线	3	
	可单独出远门，能很快掌握新环境的方位	5	
人物定向	只认识保护人，不辨熟人和生人	0	
	只认识常同住的亲人，可称呼子女或孙子女，可辨熟人和生人	1	
	只能称呼家中人，或只能照样称呼，不知其关系，不辨辈分	2	
	只知家中亲密近亲的关系，不会分辨陌生人的大致年龄，不能称呼陌生人	3	
	知道周围人们的关系，知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义；可分辨陌生人的大致年龄和身份，可用适当称呼	5	
记忆	记忆完全紊乱或完全不能对既往事物进行正确的回忆	0	
	出现重度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆远期记忆，不记得自己的老朋友)	1	
	出现中度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆近期记忆，不记得上一顿饭吃了什么)	2	
	出现轻度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆即时信息，3 个词语经过 5 分钟后仅能回忆 0~1 个)	3	
	总是能够保持与社会、年龄所适应的长、短时记忆，能够完整的回忆	5	
攻击行为	过去 3 天里天天出现	0	
	过去 3 天里出现过一两次	1	
	每周出现一两次	2	

	每月出现一两次	3	
	没出现	5	
抑郁症状	过去 3 天里天天出现	0	
	过去 3 天里出现过一两次	1	
	每周出现一两次	2	
	每月出现一两次	3	
	没出现	5	
强迫行为	过去 3 天里天天出现	0	
	过去 3 天里出现过一两次	1	
	每周有 1 次~2 次强迫行为	2	
	每月有 1 次~2 次强迫行为	3	
	无强迫症状(如反复洗手、关门、上厕所等)	5	
财物管理	无法管理	0	
	接触金钱机会少，主要由家属代管	1	
	因担心算错，每月管理约 300 元	2	
	因担心算错，每月管理约 1000 元	3	
	金钱的管理、支配、使用，能独立完成	5	
评估对象姓名：	评估人员：	评估时间：	

认知能力受损等级分为 4 档，按表 2 中分值累计情况确定受损等级：

a) 能力完好：总分 40 分；

b) 轻度受损：总分 8 分~39 分；

c) 中度受损：总分 3 分~7 分；

d) 重度受损：总分 0~2 分。

表3　感知觉与沟通能力评估

项目	能力表现	分值	
意识水平	昏迷，处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情；处于深昏迷时对刺激无反应	0	
	昏睡，一般的外界刺激不能使其觉醒，给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒，醒后可简短回答提问，当刺激减弱后又很快进入睡眠状态	1	
	嗜睡，表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动其肢体时可唤醒，并能进行正确的交谈或执行指令，停止刺激后又继续入睡	2	
	神志清醒，对周围环境警觉	3	
视力	没有视力，眼睛不能跟随物体移动	0	
	辨认物体有困难，但眼睛能跟随物体移动，只能看到光、颜色和形状	1	
	视力有限，看不清报纸标准字体，但能辨认物体	2	
	视力完好，能看清书报上的标准字体	3	
听力	完全听不见	0	
	正常交流有些困难，需在安静的环境、大声说话或语速很慢，才能听到	1	
	在轻声说话或说话距离超过 2 米时听不清	2	
	可正常交谈，能听到电视、电话、门铃的声音	3	
沟通交流	不能表达需要或理解他人的话	0	
	勉强可与人交往，谈吐内容不清楚，表情不恰当	1	
	能够表达自己的需要或理解别人的话，但需要增加时间或给予帮助	2	
	无困难，能与他人正常沟通和交流	3	
评估对象姓名：　　评估人：　　评估时间：			
注 1：若评定为昏迷，直接评定为重度失能，可不对视力、听力、沟通交流三项能力进行评估。 注 2：若平日佩戴老花镜或近视镜，应在佩戴眼镜的情况下评估视力。 注 3：若平时佩戴助听器，应在佩戴助听器的情况下评估听力。 注 4：沟通交流评估应包括非语言沟通。			

感知觉与沟通能力受损等级分为 4 档，按表 3 中分值累计情况确定受损等级：

a) 能力完好：总分 12 分；
b) 轻度受损：总分 8 分~11 分；
c) 中度受损：总分 4 分~7 分；
d) 重度受损：总分 0~3 分。

附件 4

舟山市长期护理保险失能等级划分表

日常生活活动 受损等级	认知能力 受损等级	感知觉与沟通能力 受损 等级	失能等级
能力完好	能力完好或轻度受损	能力完好或轻度受损	0 级(基本正常)
	中度或重度受损	任一等级	1 级(轻度失能)
	任一等级	中度或重度受损	
轻度受损	能力完好或轻度受损或中度受损	能力完好或轻度受损或中度受损	
	重度受损	任一等级	2 级(中度失能)
	任一等级	重度受损	
中度受损	能力完好或轻度受损或中度受损	能力完好或轻度受损或中度受损	
	重度受损	任一等级	3 级(重度失能Ⅰ级)
	任一等级	重度受损	
重度受损	能力完好或轻度受损	能力完好或轻度受损	
	中度受损	能力完好或轻度受损或中度受损	4 级(重度失能Ⅱ级)
	能力完好或轻度受损或中度受损	中度受损	
重度受损	重度受损	任一等级	5 级(重度失能Ⅲ级)
	任一等级	重度受损	

附件 5

舟山市 xx 县(区)长期护理保险
重度失能人员名单公示

根据《舟山市长期护理保险失能等级评估管理办法》(舟医保发〔20xx〕xx 号),现将 20xx 年 xx 月份长期护理保险失能等级评估结论为重度失能的人员名单进行公示，公示期为 20xx 年 xx 月 xx 日到 20xx 年 xx 月 xx 日止(名单详见附件)。

公示期间，对评估结果有异议的，可向辖区医保经办机构举报和投诉。

为便于调查核实，请实名反映问题，并提供联系方式，我们将按有关规定予以保密。

联系电话：0580-XXXXXXXXXXX

附件：舟山市 XX 县（区）长期护理保险重度失能人员名单

XXX 长期护理保险失能等级评估委员会办公室

20xx 年 xx 月 xx 日

附件

舟山市xx县(区)长期护理保险重度失能人员名单

(20xx年xx月第x批)

序号	姓名	身份证号	机构/街道社区（村）	失能等级
1	张*娣	33090319****160910	xxx养老院	重度失能Ⅰ级
2	李*月	33090319****160910	XX医院	重度失能Ⅱ级
3	王*	33090319****160910	Xx街道XX社区	重度失能Ⅲ级
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

附件 6

舟山市长期护理保险失能等级评估结论书

(XXX 长护险评估编号)2024xxxx

被评估人姓名:　　身份证号码:

户籍地址:xx 县（区）xx 乡镇（街道）xx 村（社区）

居住地址：xx 县（区）xx 乡镇（街道）xx 村（社区）xx 路 xx 号（xx 小区 xx 幢 xx 室）/xxx 机构

评估类型：初次评估/状态变更评估/定期评估

根据《长期护理保障失能等级评估规范》,经评估人员现场评估、失能等级评估委员会确认，您目前的失能等级评估结论为：基本正常/轻度失能/中度失能/重度失能 I 级/重度失能 II 级/重度失能III级。

如您对本次评估结论有异议，可以自收到本次评估结论书之日(　　年　月　日)起 5 个工作日内向辖区医保经办机构提出复评申请，逾期视作认同。

XXX 长期护理保险失能等级评估委员会

20xx 年 xx 月 xx 日

附件 7

舟山市长期护理保险失能等级复评（争议、抽查、稽核）评估结论书

（xxx 长护险复评（争议、抽查、稽核）评估编号）2022xxxx

被评估人姓名：　　身份证号码：

户籍地址：xx 县（区）xx 乡镇（街道）xx 村（社区）

居住地址：xx 县（区）xx 乡镇（街道）xx 村（社区）xx 路 xx 号（xx 小区 xx 幢 xx 室）/xxx 机构

评估类型：争议复评/抽查复评/稽核复评

根据《长期护理保障失能等级评估规范》，经评估人员现场评估、失能等级评估委员会确认，您目前的失能等级评估结论为：基本正常/轻度失能/中度失能/重度失能 I 级/重度失能 II 级/重度失能III级。

本次评估结论为最终结论。

XXX 长期护理保险失能等级评估委员会

20xx 年 xx 月 xx 日

附件 8

舟山市长期护理保险失能等级评估结论书送达回执

本人已收到申请人　　的失能等级评估结论书(XXX 长护险评估编号)2024xxxx、（xxx 长护险复评（争议、抽查、稽核）评估编号）2022xxxx，已知晓评估结论及相关事项。

送达人:　　送达日期:

签收人:　　签收日期:

抄送：市、县（区）医保经办机构

舟山市医疗保障局办公室　　2024年3月8日印发